BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS

ACR : mises au point et nouveautés

FMA des chefs d'agrès
2025 - 2026



Évolution de la prise en charge de l'ACR

- Depuis longtemps, les secouristes ne contrôlent plus le pouls après la délivrance d'un choc électrique.
- En effet, si elle avait un pouls, la victime était mise en PLS, elle était le plus souvent mal surveillée.
- Or, comme « nul n'est plus à même de faire un ACR que celui ou celle qui vient de faire un ACR ! », lorsqu'elle repassait en ACR, personne ne s'en rendait compte…



Évolution de la prise en charge de l'ACR

- Comme « nul n'est plus à même de faire un ACR que celui ou celle qui vient de faire un ACR », alors si le DSA a déjà choqué une fois, il effectue une analyse du rythme cardiaque sans faire interrompre le massage cardiaque des secouristes. Si la victime est encore/de nouveau en FV, il ordonne alors un nouveau choc AVANT les 2 minutes habituelles (mode AWC).

- C'est la BSPP qui a demandé au constructeur de faire évoluer son produit dans le but d'améliorer la qualité de la prise en charge des victimes. On a beaucoup de données qui nous permettent de comprendre l'ACR et d améliorer les pratiques.

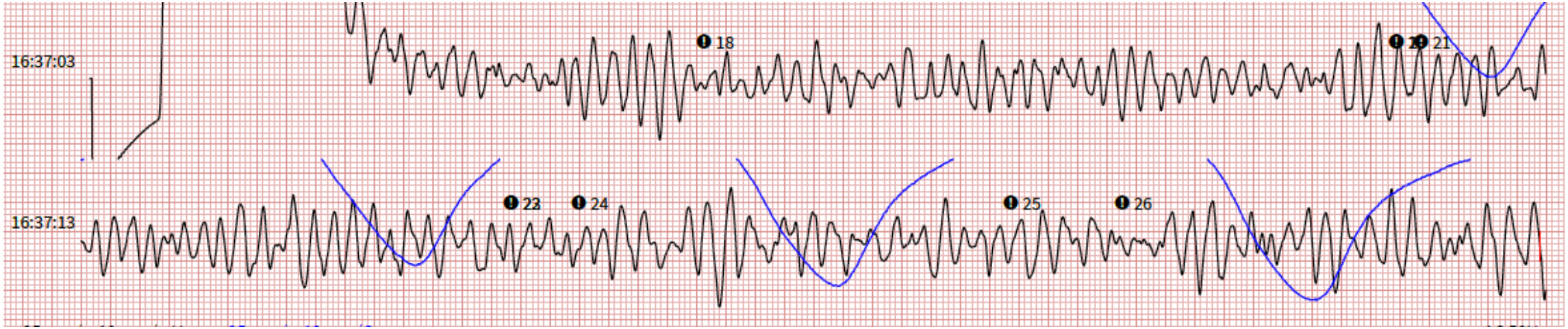
Évolution de la prise en charge de l'ACR

- « Le DSA a toujours raison : s'il demande de choquer, on choque ! »
- « On n'interrompt jamais le massage cardiaque à part si la victime se réveille, nous parle ou répond aux ordres simples (serrez-moi la main) ».
- Dans ce cas, on reste en mode DSA, 2 minutes après celui-ci refait une analyse, et s'il demande de choquer, alors on choque, même si la victime est consciente !



Évolution de la prise en charge de l'ACR

- On avait insisté sur les signes de vie per-RCP :
  - certains ACR (de cause cardiaque, par exemple les troubles du rythme, les infarctus…) peuvent présenter dans les premiers instants de l'arrêt cardiaque des signes de vie, voire une respiration !
  - En effet, au moment où survient l'arrêt cardiaque de cause cardiaque, le massage cardiaque précoce fait circuler du sang oxygéné dans le cerveau, ce qui peut donner à voir des signes de vie : ce sont des ACR de bon pronostic !



J’arrive sur intervention, la victime est inconsciente, ne respire pas et a un pouls carotidien. Que dois-je faire ?

Je masse et je pose le DSA !

Évolution de la prise en charge de l'ACR

- En 2023, l'arrêt respiratoire a disparu (hors contexte d'intoxication aux opiacés) :

Bilan primaire d'une victime inconsciente

RESPIRATION	oui	non contexte overdose	non autres situations	oui	non
CIRCULATION	oui	oui	oui	non	non
ÉTAT	inconscience	arrêt respiratoire	arrêt cardiaque	arrêt cardiaque	arrêt cardiaque
CONDUITE À TENIR	PLS ou sur le dos avec LVA	insufflations +/- CAT spécifique	RCP	RCP	RCP

Donc, nouvelle définition de l'ACR :

ACR = pas de pouls carotidien OU gasps

OU pas de respiration (hors intoxication aux opiacés)

J'arrive sur intervention, le requérant masse. Je refais un bilan primaire ?

Oui !

J'arrive sur intervention, le requérant masse. Le DAE public a déjà choqué. Je refais un bilan primaire ?

Non !

Si il y a eu un CEE chez une victime inconsciente, cela ne peut pas être autre chose qu'un ACR.

J'arrive sur intervention, le requérant masse. Le DAE public a déjà choqué. Je laisse le DAE ?

Non !

On change et on met notre DSA.

En effet les DAE sont beaucoup plus lents

que nos DSA dans les analyses

et les ordres donnés aux secouristes.

Dans quelles situations je masse immédiatement à la perte de connaissance de la victime sans refaire un BP complet ?

- PC lors d'un infarctus diagnostiqué par le médecin coordinateur sur lecture de l'ECG
- PC lors d'une DT typique de douleur coronarienne
- PC lors d'une OBVA par corps étranger
- PC chez un ACR qui se serait réveillé grâce à la RCP

Pour rappel, quelles sont les précautions à prendre quand on utilise le DSA ?



Ne pas être sur du métal

Ne pas être en milieu humide

Et attention à la couverture de survie !



On a eu d'ailleurs eu récemment

un cas de défibrillation d'une victime reposant sur une couverture de survie

avec bruit de claquement sous la victime

au moment de la délivrance du choc

Qui pose le DSA ?



- Peu importe qui le pose !
- L'important c'est qu'il soit posé vite ET bien !
- En revanche, c'est logiquement le CA qui commence le massage cardiaque, car c'est lui qui s'est rendu compte de l'ACR lors du BP.

Comment poser les patchs DSA ?

Patch antérieur :

grand côté parallèle à

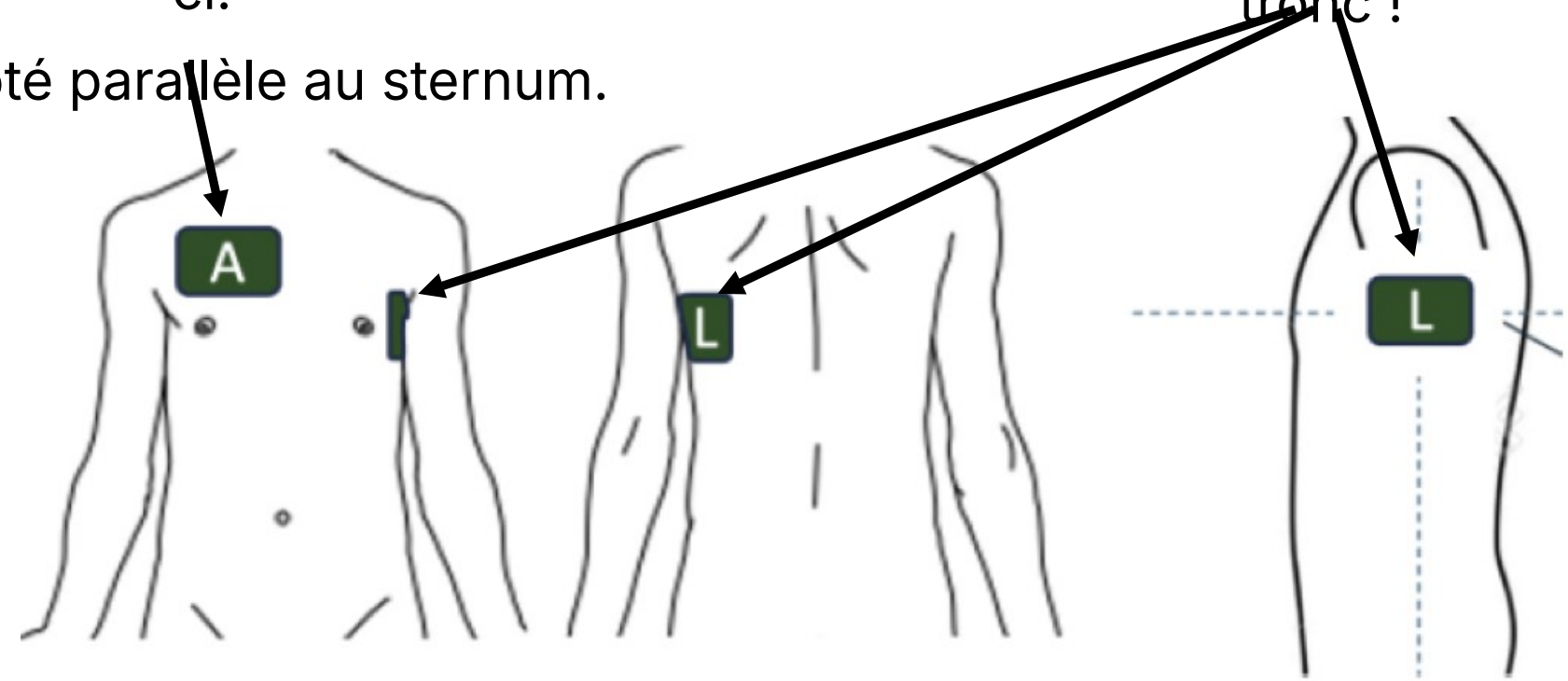
la clavicule droite, juste sous celle-ci.

Petit côté parallèle au sternum.

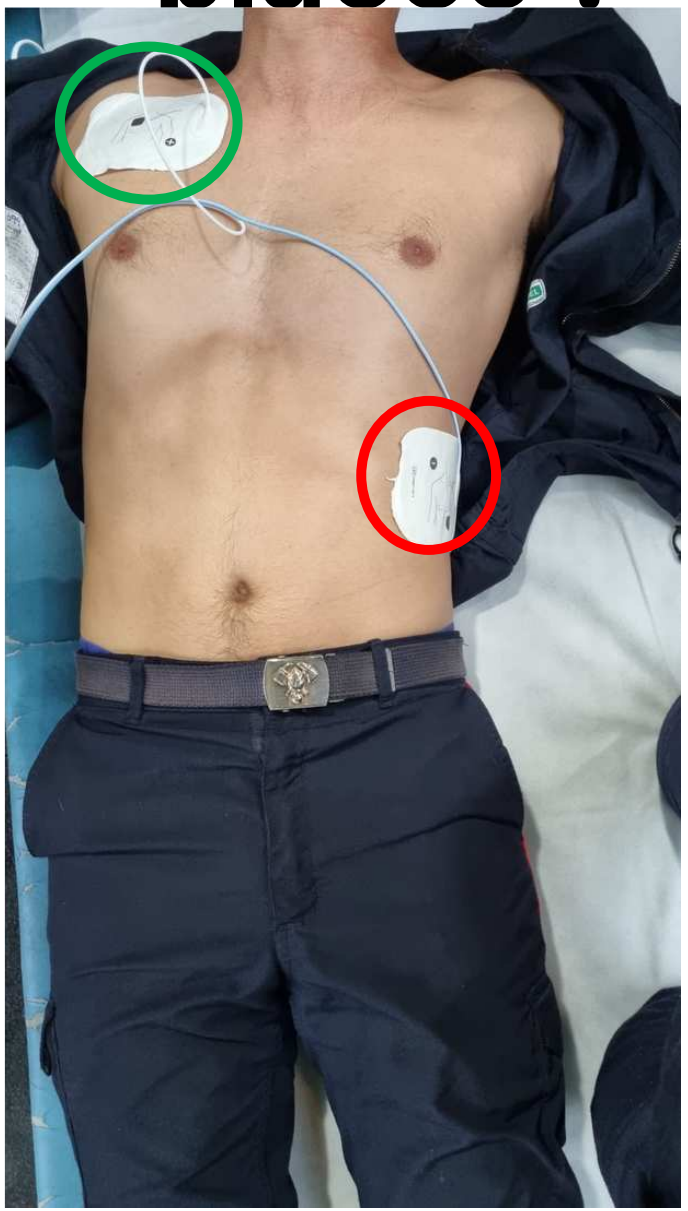
Patch latéral : à la jonction

ligne mamelonnaire/ligne médio-axillaire.

Il faut donc écarter le bras gauche du tronc !

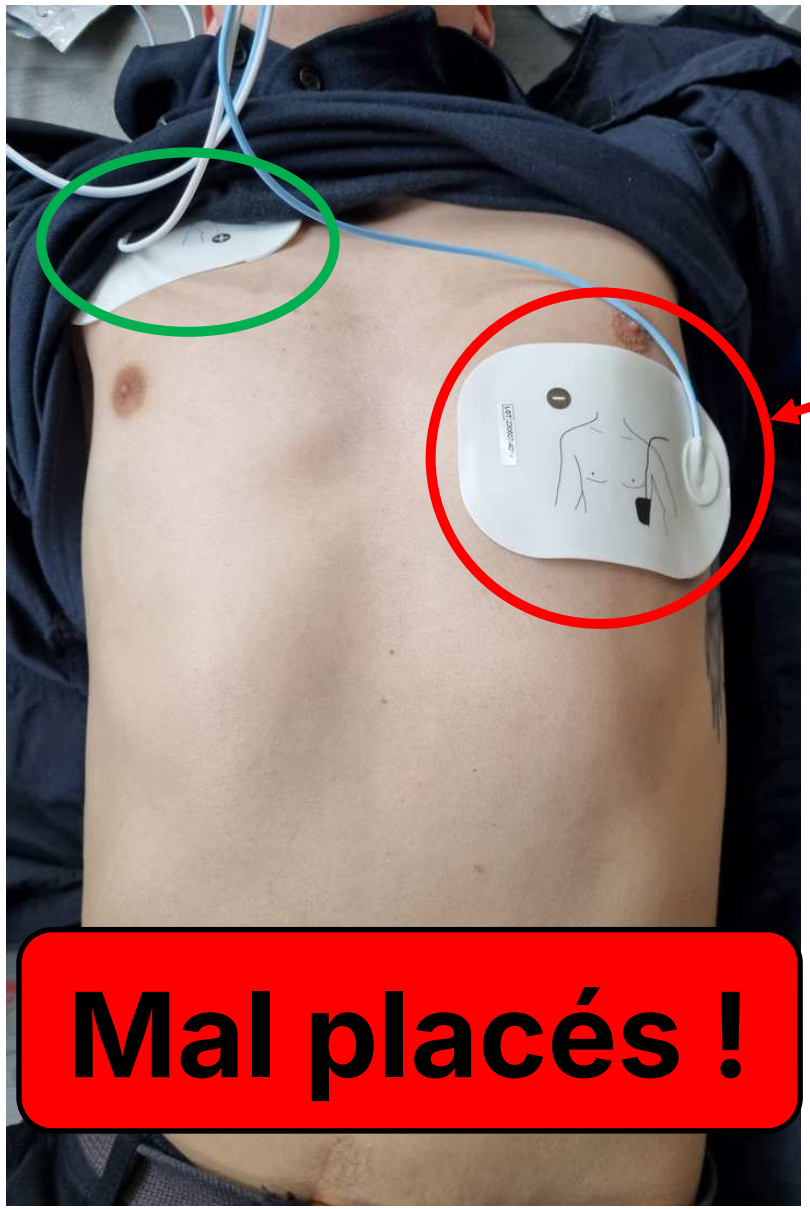


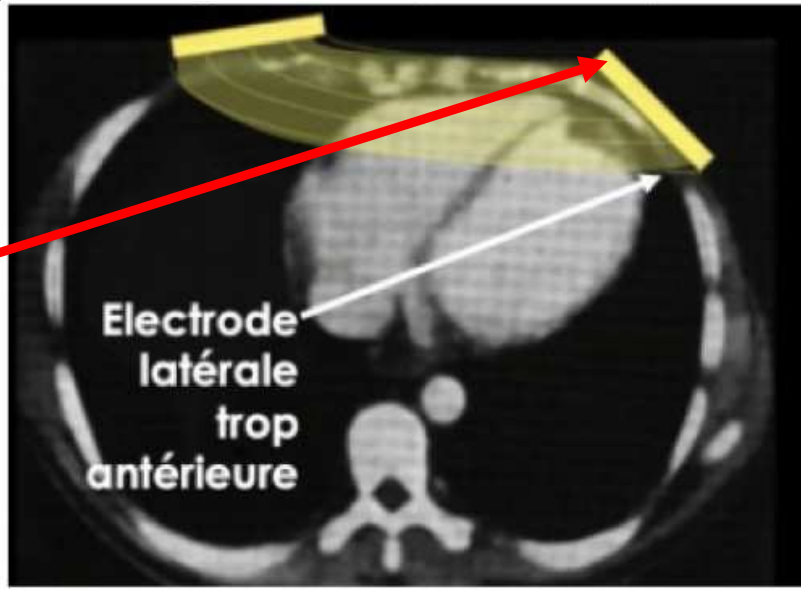
Quiz : patchs bien placés ou mal placés ?

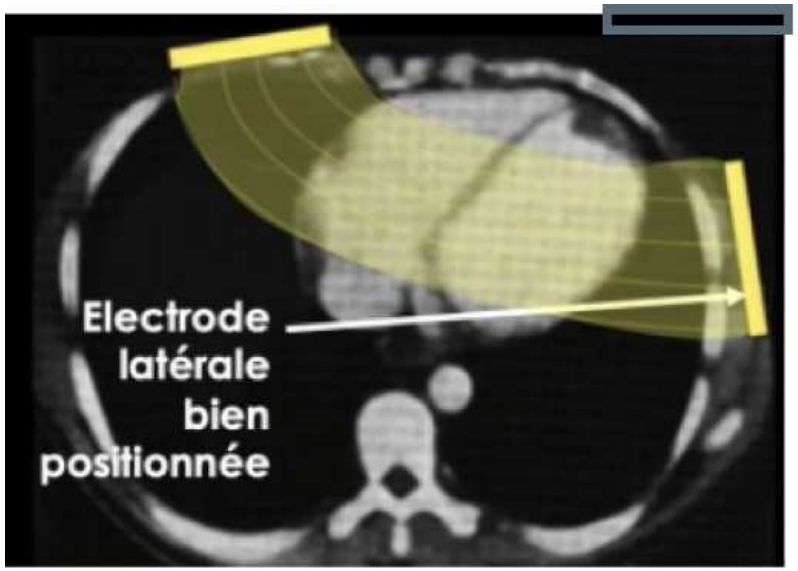


Mal placés !

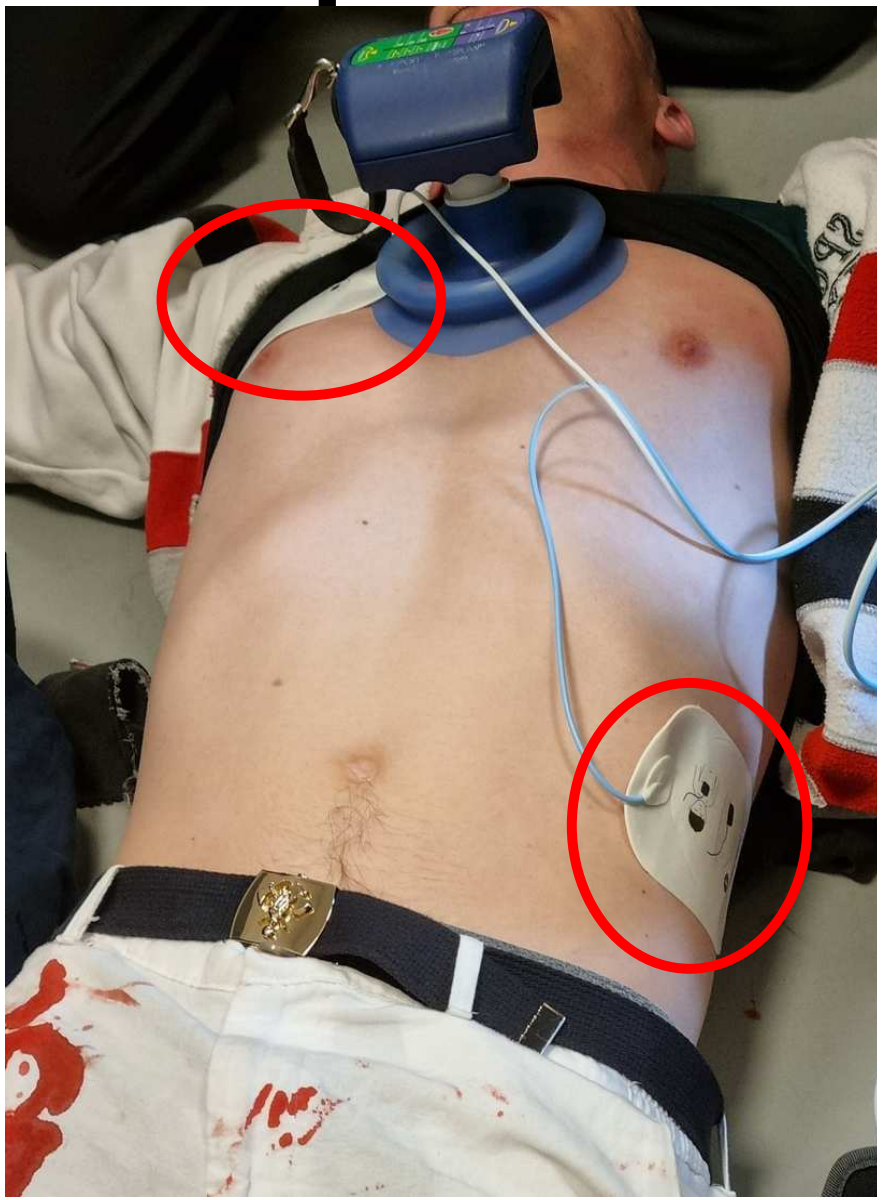
Quiz : patchs bien placés ou mal placés ?







Quiz : patchs bien placés ou mal placés ?



Mal placés !

Quiz : patchs bien placés ou mal placés ?

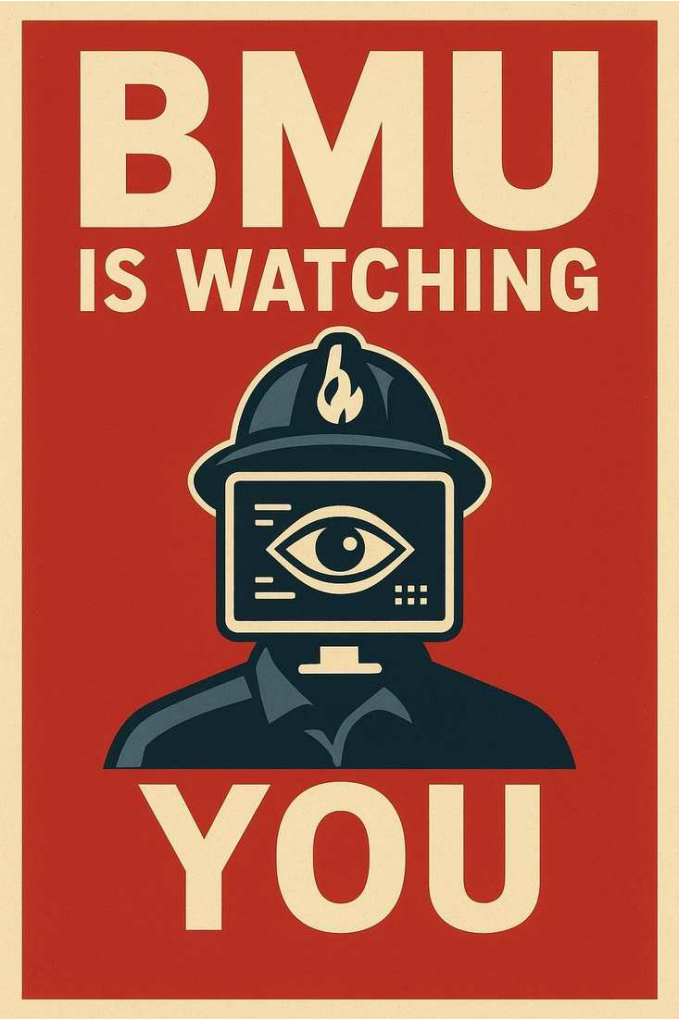


Mal placés !

Au fait, doit-on pré-connecter les patchs au DGT7 ?

Oui !

Dans 7,5 % des cas
où le DGT7 a été utilisé,
les patchs DSA
n'étaient pas pré-connectés !



Qui choque lorsque le DSA propose un choc ?

- Tout le monde peut choquer, même les équipiers !
- On doit avoir le doigt sur le bouton choc lors de l'analyse et choquer le plus tôt possible, sans attendre la fin du message du DSA qui dit de choquer.
- Il faut absolument reprendre le massage cardiaque dès la délivrance du choc, sans attendre la fin du message du DSA qui dit de reprendre le MCE.



Nouveau : le message radio 4C-N

- C'est le message d'ambiance de l'ACR !
- But ?
  - Informer la coordination médicale pour ajuster l'envoi des moyens, notamment l'équipe de circulation extra-corporelle (ECMO)
  - Il permet aussi d'ajuster les moyens si la victime n'est pas en ACR…
- Qui ?
  - Le CA du premier engin présenté sur ACR, après avoir entamé la RCP, transmet un message radio sur SGAP-COORD.
  - S'il n'a pas eu le temps de le faire, il le délègue au CA du second engin



Nouveau : le message radio 4C-N

- Quand ?
  - Pas tout le temps !
  - Si la victime tombe en ACR devant le CA ;
  - Si le CA découvre une victime en ACR (hors procédure rouge) ;
  - Si le CA part pour ACR et qu'il reçoit l'ordre de le faire par la coordination médicale.
- Si départ en procédure rouge pour ACR et que la CM l'a demandé :
  - après le BP, le MCE, la pose du DSA et la défibrillation !
- Si découverte d'une victime en ACR :
  - le 4C-N permet aussi la demande d'équipe médicale par radio.

Nouveau : le message radio 4C-N

- **C**ONFIRMATION :
  - Je confirme l'ACR
- **C**IRCONSTANCES :
  - Circonstances ayant mené à l'ACR (DT post effort, DRA, OBVA, traumatisme…)
- **C**OMORBIDITÉS = **C**O-PATHOLOGIES :
  - Principaux antécédents pertinents dans le contexte d'ACR
- **C**HOCS :
  - Nombre d'analyses et nombre de chocs
- **N**O-FLOW :
  - Estimation du NF ou NF inconnu

Exemple n°1 de 4C-N

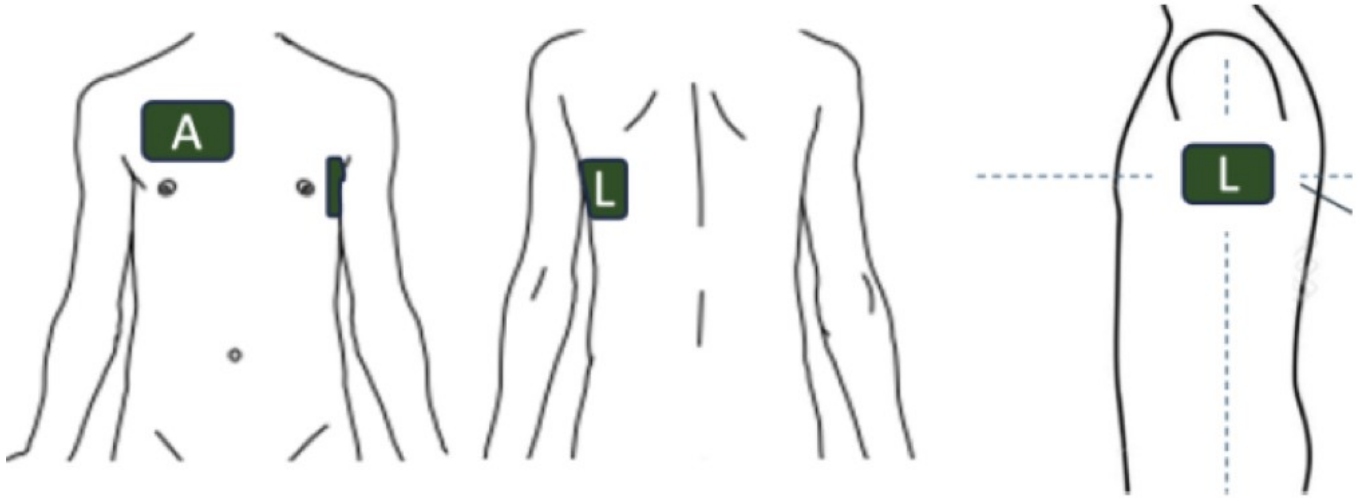
- **C :** Je confirme l'ACR d'un homme de 40 ans environ…
- **C :** …survenu lors d'une douleur thoracique à l'effort.
- **C :** Notion de cholestérol et d'hypertension.
- **C :** 2 analyses, 2 chocs, signes de vie pendant le massage.
- **N :** NF 0 car massé immédiatement par des témoins.

Exemple n°2 de 4C-N

- **C :** Je confirme l'ACR d'une femme de 90 ans environ…
- **C :** …retrouvée par infirmière à domicile dans son lit.
- **C :** GIR 2, insuffisance respiratoire chronique, cancer pulmonaire.
- **C :** 1 analyse, pas de choc.
- **N :** NF inconnu, vue la dernière fois en vie à 1h du matin.

Que fait le CA quand il se réinclut dans la RCP après avoir passé ses messages radio ?

Il vérifie la position des patchs DSA !





Que fait le second CA en arrivant sur ACR ?

- Il vérifie la position des patchs DSA !
- Il vérifie que le 4C-N a bien été passé et propose au premier CA de le faire le cas échéant.
- Il prend le time-keeper et organise les relais, en notant sur eFiBi les horaires des analyses, des chocs. C'est le secrétaire de l'intervention, il se met à disposition de l'équipe médicale qui pourra lui demander de noter des éléments lors de la réanimation (heure d'intubation, heure de passage des drogues, heure de reprise d'activité cardiaque...).



Que fait le second CA en arrivant sur ACR ?

- Il fait initier les insufflations à 4 mains (étanchéité du masque)



Que fait le second CA en arrivant sur ACR ?

- Il commence ainsi à remplir eFiBi et couple la tablette du premier engin de prompt secours au DGT 7.
- Il permet donc de dégager du temps au premier CA qui peut :
  - Préciser le circonstanciel, le MHTA auprès des proches/famille/requérant ;
  - Informer ceux-ci !



Quels éléments doit-on transmettre à l'équipe médicale quand elle arrive sur un ACR ?

Ceux du 4C-N !

- Circonstances
- Comorbidités
- Chocs

et

Et :

- Signes de vie
- Durée de la réanimation

analyses

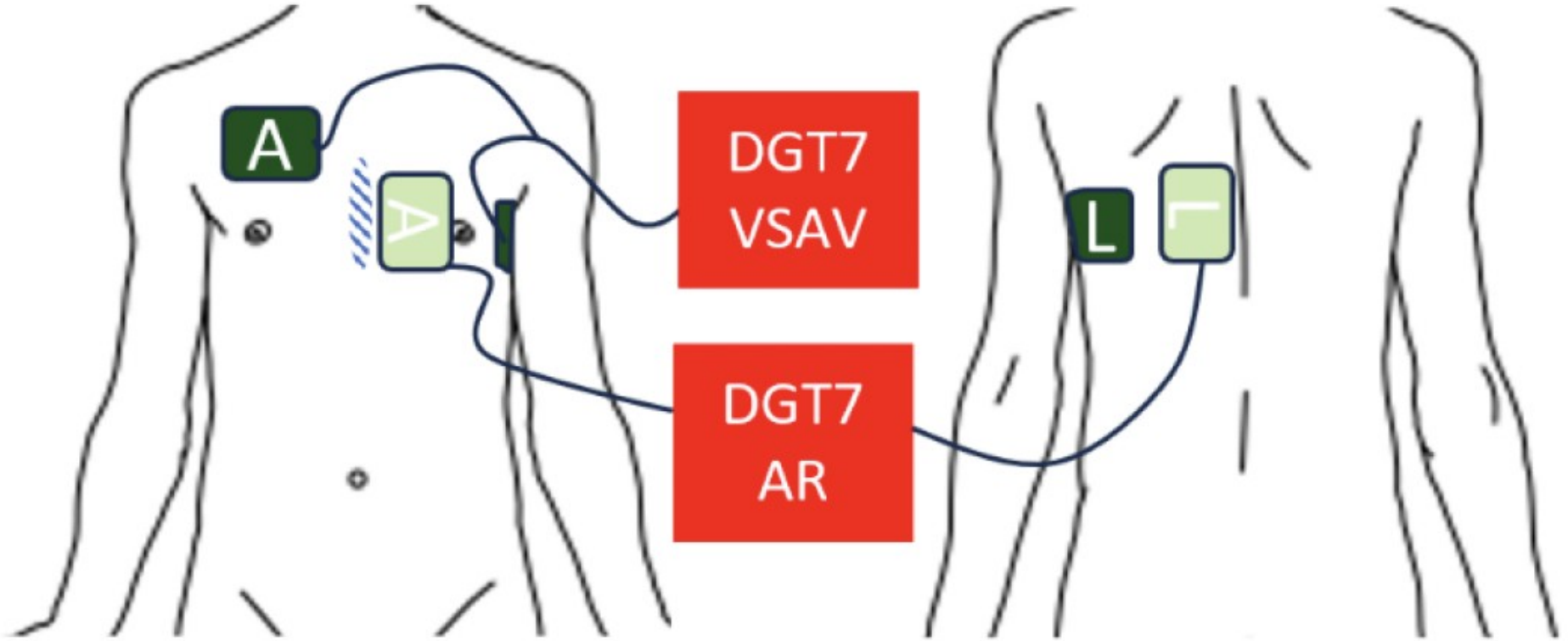
- No-Flow

Le nombre de chocs et la durée de la réanimation sont visibles sur l'écran du DGT7

Nouveau : la double défibrillation

- Pour information des secouristes uniquement, car la manœuvre sera entièrement sous la direction de l'équipe médicale.
- Depuis peu, les équipes médicales peuvent décider de défibriller simultanément avec deux défibrillateurs (et donc 2 paires de patchs) une victime ayant déjà été choquée par les premiers secours.
- Le but est d'augmenter l'efficacité de la défibrillation en visant à la fois toutes les parties du cœur.
- Le premier risque est de perdre du temps de massage cardiaque lors de la manœuvre. Ceci peut être limité par un briefing de tous les personnels avant la manœuvre. Ce briefing est à la main de l'équipe médicale.
- Le second risque, rare, est d'endommager un des défibrillateurs, c'est pourquoi il faut réaliser en fin d'intervention un auto-test des deux défibrillateurs impliqués.

Nouveau : la double défibrillation



Disparition de la cardiopompe

- Fin de production par le constructeur.
- Nouveau dispositif de contrôle de l'efficacité du massage cardiaque : le LifePoint
- Mise en place progressive, formation dans les CS, en commençant par le G3.





Administratif

- L'ACR est la seule situation où l'on crée encore une victime dans le rapport d'intervention afin d'envoyer le mail en 13 points.
- Désormais il faut renseigner la MCO avec l'identité du citoyen sauveteur en tout lieu (auparavant appelé Bon Samaritain) et des témoins qui ont massé sur VP ou en lieu public. L'objectif sera de les remercier d'avoir aidé à sauver une vie.

Simplification : Disparition des insufflations starter

- Cela va paraitre bientôt dans la mise à jour du PSC1 et du PSE.
- En effet, le matériel d'insufflation n'était quasiment jamais prêt.
- L'avantage est de n'avoir plus qu'une seule procédure.

Simplification :
Plus besoin de photo des patchs DSA

- Ils sont en effet automatiquement reconnus par le DGT7 : la traçabilité est assurée.
- Cependant, en cas de problème de défibrillation, il faut les garder pour analyse !

Vous arrivez sur intervention, la FC est à 200, la victime a un antécédent de maladie de Bouveret. Que faire ?

- On appelle en urgent la CM, on fait les gestes de sauvegarde (allongé, oxygène).
- En aucun cas on fait la manœuvre de Valsalva sans prescription médicale !
- Qui nous dit que ce jour là, la victime n'est pas en train de faire une tachycardie grave qui peut évoluer en ACR ?
- Dans ces conditions, faire la manœuvre de Valsalva sans ECG interprété par un médecin et donc sans prescription médicale peut s'avérer délétère pour la victime !

Conclusion

- ACR = pas de pouls carotidien OU gasps OU pas de respiration (sauf contexte opiacés).
- On n'interrompt jamais un massage cardiaque (le moins possible).
- Il faut défibriller le plus vite possible et correctement en plaçant les patchs au bon endroit.
- Nouveauté : le 4C-N.
- Les équipes médicales vont parfois faire de la double défibrillation.
- La cardiopompe va disparaitre. Le LifePoint arrive.